



Jornadas de Actualización en Atención Primaria (JAP)

Programa docente 2026-2027

Formato	Sesiones clínicas prácticas, centradas en problemas frecuentes de Atención Primaria.
Modelo docente	Sesiones impartidas por R1, autorizadas y revisadas por R4 y tutores/as de Atención Primaria.
Periodo	Del 04-09-26 al 14-05-27.
Producto común	Infografía clínica o material equivalente por sesión, revisado y reutilizable.

Documento de planificación docente. Mantiene el estilo gráfico sobrio de la tabla inicial: retícula negra, tipografía serif y rellenos azul grisáceo.



MARCO GENERAL

Objetivo general	Mejorar la capacidad de resolución clínica en Atención Primaria mediante sesiones prácticas, supervisadas y orientadas a decisiones de consulta: diagnóstico inicial, tratamiento, seguimiento, educación sanitaria y criterios de derivación.
Modelo docente	Cada sesión será preparada y presentada por R1. Antes de su exposición deberá ser autorizada por un R4 y por el tutor/a de Atención Primaria correspondiente. No se asignan sesiones a organizadores como ponentes.
Producto final	Cada sesión deberá entregar una infografía clínica o material de consulta equivalente. La jornada final reunirá los materiales en un banco común de recursos.

Rol	Función
R1 responsable	Preparación y exposición principal de la sesión, con apoyo en casos clínicos y material final.
R4 supervisor	Revisión clínica, estructura docente, algoritmos, criterios de derivación y mensajes clave.
Tutor/a AP	Autorización final, adecuación al contexto de Atención Primaria y validación de aplicabilidad.
EIR / Enfermería	Participación cuando proceda en educación sanitaria, autocuidados, seguimiento y continuidad asistencial.
Adjunto/a colaborador/a	Apoyo puntual en áreas clínicas específicas o coordinación con otros servicios.



CALENDARIO GENERAL

Nº	Fecha	Sesión	Orientación	Producto final
1	04-09-26	Síndrome cardiorenal metabólico	Integración clínica cardiometabólica y renal	Infografía marco del programa
2	25-09-26	Hipertensión arterial	Prevención cardiovascular y manejo longitudinal	Algoritmo diagnóstico-terapéutico
3	16-10-26	Diabetes mellitus	Cronicidad, riesgo vascular y complicaciones	Tabla de manejo inicial
4	06-11-26	Dislipemia	Riesgo cardiovascular y decisión terapéutica	Mapa de decisión terapéutica
5	27-11-26	Insuficiencia cardíaca	Cronicidad, diagnóstico inicial y descompensación	Checklist de IC en AP
6	18-12-26	Obesidad	Abordaje integral y longitudinal	Infografía de intervención escalonada
7	15-01-27	EPOC y asma	Respiratorio frecuente en AP	Guía de inhaladores y crisis
8	05-02-27	Dispepsia, ERGE y SII: manejo inicial en AP y criterios de derivación	Digestivo frecuente y uso racional de pruebas	Algoritmo digestivo de AP
9	26-02-27	Ansiedad, depresión, insomnio y desprescripción de BZD	Salud mental frecuente y seguridad clínica	Plan de desprescripción
10	19-03-27	Anticoncepción, menopausia y TRH: diagnóstico y tratamiento	Salud de la mujer en AP	Tabla de elección terapéutica
11	09-04-27	Manejo del dolor	Síntoma transversal, seguridad e iatrogenia	Escalera analgésica práctica
12	30-04-27	Atención integral del adulto mayor	Geriatría AP, fragilidad y continuidad	Checklist geriátrico
13	14-05-27	Jornada final	Síntesis, transferencia y banco común de materiales	Banco final de infografías

Campos nominales pendientes de asignar: R1 responsable, R4 supervisor y tutor/a de AP. La primera sesión mantiene el lugar Edificio J y la jornada final la Sala de Actos D, según la planificación inicial.



SESIÓN 1: Síndrome cardiorenal metabólico

Fecha	Lugar	Orientación	Producto final
04-09-26	Edificio J	Integración clínica cardiometabólica y renal	Infografía marco del programa

Objetivos docentes
• Comprender el síndrome cardiorenal metabólico como eje común de riesgo en AP. • Identificar datos clínicos y analíticos que obligan a intensificar el seguimiento. • Relacionar diabetes, HTA, dislipemia, obesidad, ERC e insuficiencia cardiaca en una misma hoja de decisión. • Definir qué problemas se resuelven en AP y cuáles requieren coordinación o derivación.
Subtemas a tratar
• Concepto práctico: paciente cardiometabólico, renal y pluripatológico. • Cribado inicial: PA, IMC, perímetro abdominal, HbA1c/glucemia, perfil lipídico, eFG, albuminuria y ECG si procede. • Estratificación de riesgo cardiovascular y renal. • Objetivos generales de control y seguimiento longitudinal. • Tratamientos con impacto cardiorenal: estilo de vida, control tensional, estatinas, antidiabéticos con beneficio cardiorenal cuando proceda. • Criterios de alarma, derivación y coordinación con Cardiología, Nefrología, Endocrino o Medicina Interna. • Cómo usar esta sesión como marco común para el resto del programa.
Producto mínimo esperado
Infografía clínica de una página, con problema de consulta, decisión inicial, manejo, criterios de alarma/derivación y bibliografía abreviada.

R1 responsable	R4 supervisor	Tutor/a AP
Por asignar	Por asignar	Por asignar



SESIÓN 2: Hipertensión arterial

Fecha	Lugar	Orientación	Producto final
25-09-26	Por confirmar	Prevención cardiovascular y manejo longitudinal	Algoritmo diagnóstico-terapéutico

Objetivos docentes
• Confirmar correctamente el diagnóstico de HTA y evitar errores de medida. • Estratificar el riesgo y fijar objetivos individualizados. • Elegir tratamiento inicial y escalado terapéutico razonado. • Diferenciar mal control, urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva.
Subtemas a tratar
• Medición correcta en consulta, AMPA y MAPA. • Diagnóstico inicial, HTA de bata blanca, HTA enmascarada y pseudorresistencia. • Evaluación básica: anamnesis, exploración, analítica, albuminuria, ECG y daño de órgano diana. • Medidas no farmacológicas con impacto real. • Tratamiento farmacológico inicial y combinaciones frecuentes. • Seguimiento, adherencia, efectos adversos e inercia terapéutica. • HTA secundaria: cuándo sospecharla. • Criterios de derivación y manejo de cifras muy elevadas.
Producto mínimo esperado
Infografía clínica de una página, con problema de consulta, decisión inicial, manejo, criterios de alarma/derivación y bibliografía abreviada.

R1 responsable	R4 supervisor	Tutor/a AP
Por asignar	Por asignar	Por asignar



SESIÓN 3: Diabetes mellitus

Fecha	Lugar	Orientación	Producto final
16-10-26	Por confirmar	Cronicidad, riesgo vascular y complicaciones	Tabla de manejo inicial

Objetivos docentes
• Individualizar objetivos de control glucémico y cardiovascular. • Seleccionar tratamiento inicial según perfil clínico, comorbilidad y preferencias. • Detectar precozmente complicaciones microvasculares y macrovasculares. • Planificar seguimiento estructurado desde AP.
Subtemas a tratar
• Diagnóstico y clasificación práctica de diabetes en AP. • Objetivos de HbA1c según edad, fragilidad, comorbilidad y riesgo de hipoglucemia. • Metformina, iSGLT2, arGLP-1, insulina y otros fármacos: cuándo pensar en cada grupo. • Riesgo cardiovascular, renal y obesidad como condicionantes terapéuticos. • Cribado de pie diabético, ERC, retinopatía y neuropatía. • Educación diabetológica: autocontrol, alimentación, ejercicio, hipoglucemia y días de enfermedad. • Criterios de derivación a Endocrino, Nefrología, Oftalmología o Urgencias.
Producto mínimo esperado
Infografía clínica de una página, con problema de consulta, decisión inicial, manejo, criterios de alarma/derivación y bibliografía abreviada.

R1 responsable	R4 supervisor	Tutor/a AP
Por asignar	Por asignar	Por asignar



SESIÓN 4: Dislipemia

Fecha	Lugar	Orientación	Producto final
06-11-26	Por confirmar	Riesgo cardiovascular y decisión terapéutica	Mapa de decisión terapéutica

Objetivos docentes
• Interpretar el perfil lipídico en función del riesgo global. • Definir objetivos terapéuticos en prevención primaria y secundaria. • Manejar estatinas, ezetimiba y escalones posteriores desde AP. • Reconocer hipercolesterolemia familiar, mala adherencia e intolerancia real.
Subtemas a tratar
• Perfil lipídico básico y patrones frecuentes. • Cálculo de riesgo cardiovascular y categorías de riesgo. • Prevención primaria frente a secundaria. • LDL como objetivo principal y papel de triglicéridos/no-HDL. • Elección de estatina, intensidad, seguimiento y objetivos. • Ezetimiba y criterios para escalado o derivación. • Intolerancia a estatinas: cómo evaluarla sin suspender de forma innecesaria. • Sospecha de hipercolesterolemia familiar.
Producto mínimo esperado
Infografía clínica de una página, con problema de consulta, decisión inicial, manejo, criterios de alarma/derivación y bibliografía abreviada.

R1 responsable	R4 supervisor	Tutor/a AP
Por asignar	Por asignar	Por asignar



SESIÓN 5: Insuficiencia cardiaca

Fecha	Lugar	Orientación	Producto final
27-11-26	Por confirmar	Cronicidad, diagnóstico inicial y descompensación	Checklist de IC en AP

Objetivos docentes
• Sospechar IC en pacientes con disnea, edemas o intolerancia al esfuerzo. • Ordenar pruebas iniciales sin retrasar situaciones de alarma. • Conocer pilares terapéuticos y seguimiento básico en AP. • Identificar descompensación y criterios de derivación urgente.
Subtemas a tratar
• Sospecha clínica: síntomas, signos y diagnósticos diferenciales. • ECG, analítica, péptidos natriuréticos, radiografía y ecocardiografía. • IC con fracción de eyección reducida, preservada o intermedia: implicaciones prácticas. • Tratamiento de base y control de congestión. • Seguimiento: peso, PA, frecuencia cardiaca, función renal, potasio y adherencia. • Vacunación, ejercicio, educación y plan de acción ante empeoramiento. • Descompensación: cuándo ajustar diurético y cuándo derivar. • Coordinación con Cardiología, UHD o Urgencias.
Producto mínimo esperado
Infografía clínica de una página, con problema de consulta, decisión inicial, manejo, criterios de alarma/derivación y bibliografía abreviada.

R1 responsable	R4 supervisor	Tutor/a AP
Por asignar	Por asignar	Por asignar



SESIÓN 6: Obesidad

Fecha	Lugar	Orientación	Producto final
18-12-26	Por confirmar	Abordaje integral y longitudinal	Infografía de intervención escalonada

Objetivos docentes
• Valorar obesidad como enfermedad crónica y no solo como IMC elevado. • Detectar comorbilidades y factores que dificultan el cambio. • Proponer objetivos terapéuticos realistas y medibles. • Conocer cuándo plantear fármacos, cirugía o derivación.
Subtemas a tratar
• IMC, perímetro abdominal, composición corporal y riesgo cardiometabólico. • Comorbilidades: HTA, DM2, dislipemia, apnea del sueño, hígado graso, artrosis y salud mental. • Entrevista motivacional y objetivos por fases. • Plan alimentario, actividad física, sueño y reducción de sedentarismo. • Fármacos que favorecen aumento de peso y revisión terapéutica. • Tratamiento farmacológico de la obesidad: indicaciones generales y seguimiento. • Cirugía bariátrica: cuándo considerarla. • Evitar sesgo de peso y mejorar adherencia.
Producto mínimo esperado
Infografía clínica de una página, con problema de consulta, decisión inicial, manejo, criterios de alarma/derivación y bibliografía abreviada.

R1 responsable	R4 supervisor	Tutor/a AP
Por asignar	Por asignar	Por asignar



SESIÓN 7: EPOC y asma

Fecha	Lugar	Orientación	Producto final
15-01-27	Por confirmar	Respiratorio frecuente en AP	Guía de inhaladores y crisis

Objetivos docentes
• Distinguir asma, EPOC y posibles solapamientos clínicos. • Interpretar espirometría básica y síntomas de control. • Escoger tratamiento inhalado y revisar técnica. • Manejar exacerbaciones y criterios de derivación.
Subtemas a tratar
• Historia clínica respiratoria: síntomas, desencadenantes, tabaquismo y exposición laboral. • Espirometría: utilidad, criterios de obstrucción y reversibilidad. • Clasificación práctica de asma y EPOC para decidir tratamiento. • Inhaladores: dispositivos, técnica, adherencia y errores comunes. • Plan de acción en asma y EPOC. • Vacunación, ejercicio, rehabilitación y deshabituación tabáquica. • Exacerbación: manejo inicial, antibiótico/corticoide cuando proceda y seguimiento. • Criterios de derivación a Neumología o Urgencias.
Producto mínimo esperado
Infografía clínica de una página, con problema de consulta, decisión inicial, manejo, criterios de alarma/derivación y bibliografía abreviada.

R1 responsable	R4 supervisor	Tutor/a AP
Por asignar	Por asignar	Por asignar

SESIÓN 8: Dispepsia, ERGE y SII: manejo inicial en AP y criterios de derivación

Fecha	Lugar	Orientación	Producto final
05-02-27	Por confirmar	Digestivo frecuente y uso racional de pruebas	Algoritmo digestivo de AP

Objetivos docentes
• Abordar síntomas digestivos frecuentes con enfoque sindrómico. • Identificar signos de alarma y necesidad de estudio endoscópico. • Evitar tratamientos prolongados o pruebas innecesarias. • Explicar al paciente el plan de manejo y seguimiento.
Subtemas a tratar
• Dispepsia: síntomas, diagnóstico diferencial y abordaje inicial. • ERGE: medidas generales, IBP, recaídas y cuándo investigar. • SII: criterios clínicos, subtipos y banderas rojas. • H. pylori: cuándo buscar y cuándo tratar. • Uso adecuado de IBP y deprescripción. • Pruebas iniciales útiles y pruebas de bajo rendimiento. • Educación sanitaria: dieta, hábitos, expectativas y seguridad. • Criterios de derivación a Digestivo o Urgencias.
Producto mínimo esperado
Infografía clínica de una página, con problema de consulta, decisión inicial, manejo, criterios de alarma/derivación y bibliografía abreviada.

R1 responsable	R4 supervisor	Tutor/a AP
Por asignar	Por asignar	Por asignar

SESIÓN 9: Ansiedad, depresión, insomnio y desprescripción de BZD

Fecha	Lugar	Orientación	Producto final
26-02-27	Por confirmar	Salud mental frecuente y seguridad clínica	Plan de desprescripción

Objetivos docentes
• Reconocer ansiedad, depresión e insomnio en consulta breve. • Detectar riesgo suicida, consumo de sustancias y situaciones de vulnerabilidad. • Plantear tratamiento inicial farmacológico y no farmacológico. • Diseñar una retirada gradual y segura de benzodicepinas.
Subtemas a tratar
• Entrevista clínica breve y escalas útiles cuando aporten valor. • Diagnóstico diferencial: duelo, adaptación, enfermedad médica, consumo y fármacos. • Riesgo suicida: preguntas mínimas y actuación. • Ansiedad y depresión: intervención inicial, seguimiento y criterios de respuesta. • Insomnio: higiene del sueño, terapia cognitivo-conductual y uso prudente de hipnóticos. • Benzodicepinas: indicaciones limitadas, riesgos y dependencia. • Plan de reducción gradual, manejo de rebote y seguimiento. • Criterios de derivación a Salud Mental o Urgencias.
Producto mínimo esperado
Infografía clínica de una página, con problema de consulta, decisión inicial, manejo, criterios de alarma/derivación y bibliografía abreviada.

R1 responsable	R4 supervisor	Tutor/a AP
Por asignar	Por asignar	Por asignar

SESIÓN 10: Anticoncepción, menopausia y TRH: diagnóstico y tratamiento

Fecha	Lugar	Orientación	Producto final
19-03-27	Por confirmar	Salud de la mujer en AP	Tabla de elección terapéutica

Objetivos docentes
• Ofrecer consejo anticonceptivo individualizado y seguro. • Identificar contraindicaciones, interacciones y situaciones especiales. • Diagnosticar menopausia y valorar síntomas con impacto clínico. • Seleccionar TRH o alternativas según riesgos, preferencias y seguimiento.
Subtemas a tratar
• Consejo anticonceptivo centrado en preferencias y seguridad. • Métodos hormonales, no hormonales y de larga duración. • Anticoncepción de urgencia y situaciones especiales. • Contraindicaciones: migraña con aura, trombosis, tabaquismo, HTA, cáncer hormonodependiente y otros riesgos. • Menopausia: diagnóstico clínico, síntomas vasomotores, genitourinarios, sueño, ánimo y salud ósea. • TRH: indicaciones, contraindicaciones, vías y seguimiento. • Alternativas no hormonales y medidas de estilo de vida. • Criterios de derivación a Ginecología.
Producto mínimo esperado
Infografía clínica de una página, con problema de consulta, decisión inicial, manejo, criterios de alarma/derivación y bibliografía abreviada.

R1 responsable	R4 supervisor	Tutor/a AP
Por asignar	Por asignar	Por asignar



SESIÓN 11: Manejo del dolor

Fecha	Lugar	Orientación	Producto final
09-04-27	Por confirmar	Síntoma transversal, seguridad e iatrogenia	Escalera analgésica práctica

Objetivos docentes
• Caracterizar el tipo de dolor para elegir tratamiento. • Usar analgésicos con seguridad según edad, comorbilidad y riesgo. • Evitar cronificación, duplicidades y uso inadecuado de opioides. • Reconocer banderas rojas y necesidad de derivación.
Subtemas a tratar
• Dolor agudo, crónico, nociceptivo, neuropático, inflamatorio y mixto. • Historia clínica orientada: intensidad, funcionalidad, sueño, ánimo y banderas rojas. • Paracetamol, AINE, metamizol, coadyuvantes y tratamientos tópicos. • Opioides: indicaciones limitadas, seguimiento, efectos adversos y retirada. • Dolor neuropático: sospecha y opciones terapéuticas. • Intervenciones no farmacológicas y rehabilitación. • Dolor en paciente frágil, anticoagulado, renal o plurimedicado. • Criterios de imagen, derivación o urgencias.
Producto mínimo esperado
Infografía clínica de una página, con problema de consulta, decisión inicial, manejo, criterios de alarma/derivación y bibliografía abreviada.

R1 responsable	R4 supervisor	Tutor/a AP
Por asignar	Por asignar	Por asignar



SESIÓN 12: Atención integral del adulto mayor

Fecha	Lugar	Orientación	Producto final
30-04-27	Por confirmar	Geriatría AP, fragilidad y continuidad	Checklist geriátrico

Objetivos docentes
• Detectar fragilidad, deterioro funcional y problemas sociales relevantes. • Revisar objetivos terapéuticos y adecuación de medicación. • Prevenir caídas, deterioro nutricional y descompensaciones. • Coordinar seguimiento con enfermería, familia y recursos comunitarios.
Subtemas a tratar
• Valoración geriátrica breve aplicable en AP. • Fragilidad, sarcopenia, caídas y pérdida funcional. • Deterioro cognitivo, delirium, depresión y sobrecarga del cuidador. • Polifarmacia, deprescripción y adecuación terapéutica. • Nutrición, vacunas, actividad física y prevención de dependencia. • Plan de cuidados, atención domiciliaria y voluntades anticipadas cuando proceda. • Coordinación sociosanitaria y recursos comunitarios. • Criterios de derivación a Geriatría, Urgencias o Trabajo Social.
Producto mínimo esperado
Infografía clínica de una página, con problema de consulta, decisión inicial, manejo, criterios de alarma/derivación y bibliografía abreviada.

R1 responsable	R4 supervisor	Tutor/a AP
Por asignar	Por asignar	Por asignar



SESIÓN 13: Jornada final

Fecha	Lugar	Orientación	Producto final
14-05-27	Sala de Actos D	Síntesis, transferencia y banco común de materiales	Banco final de infografías

Objetivos docentes
• Integrar los contenidos trabajados durante el curso. • Revisar críticamente las infografías y algoritmos generados. • Seleccionar materiales útiles para consulta y docencia. • Definir mejoras para futuras ediciones de las JAP.
Subtemas a tratar
• Presentación breve de productos finales por sesión. • Revisión de utilidad clínica, claridad visual y aplicabilidad. • Casos integradores de Atención Primaria. • Propuestas temáticas: uso racional del medicamento en geriatría con criterios START-STOPP y manejo de la úlcera crónica. • Selección de materiales para repositorio docente. • Cierre y evaluación del programa.
Producto mínimo esperado
Banco final de infografías y algoritmos revisados, con selección de materiales de mayor utilidad para consulta y docencia.

R1 responsable	R4 supervisor	Tutor/a AP
Por asignar	Por asignar	Por asignar

CRITERIOS COMUNES DE CALIDAD

Criterio	Comprobación antes de presentar
Aplicabilidad	La sesión responde a preguntas reales de consulta de AP y evita una revisión puramente teórica.
Decisión clínica	Incluye qué hacer, qué no hacer, cuándo revisar y cuándo derivar.
Seguridad	Incluye banderas rojas, situaciones urgentes y errores frecuentes.
Continuidad	Integra seguimiento, educación sanitaria, enfermería y coordinación con otros niveles.
Revisión	Ha sido autorizada por R4 y tutor/a AP antes de la exposición.
Material final	La infografía es clara, breve, verificable y útil en consulta.

Plantilla mínima de infografía

Bloque	Contenido
Título clínico	Problema de consulta, población diana y objetivo de la infografía.
Diagnóstico	Datos clínicos, exploración, pruebas iniciales y errores frecuentes.
Manejo	Tratamiento inicial, seguimiento, autocuidado y educación sanitaria.
Derivación	Criterios de alarma, derivación preferente y derivación urgente.
Fuentes	Bibliografía abreviada, fecha de revisión y responsable de validación.